

47 - 01-Révision Sémiologie digestive + QCM (Teams) - Pr. Samlani

Et puis, je voudrais donc que vous répondiez globalement à toutes les questions. Alors, vous avez fait le cours de l'ICTER. Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent en particulier concernant ce cours ? Donc avant de commencer de répondre à la QCM, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans le cours de l'ICTER ? Donc à partir de là, je voudrais que vous répondiez à cette QCM.

Les signes en faveur d'un ICTER d'allure cholestatique sont ? Dites-moi, quelles sont vos réponses ? Les signes en faveur d'un ICTER d'allure cholestatique sont ? Envoyez-moi des réponses. Est-ce que le prurit est en faveur d'un ICTER d'allure cholestatique ? Tout le monde ? Est-ce que les selles décolorées sont en faveur d'un ICTER cholestatique ? Oui. Le test de colère qui est négatif ? Non.

En quoi consiste le test de colère ? Le taux de protrombique va se rendre normal en cas d'injection de vitamines K. D'accord. Et en cours d'un ICTER cholestatique, est-ce que ce test de colère est positif ou négatif ? Négatif. Par quel mécanisme ? Puisqu'il n'y a pas d'attente de cellules des hépatocytes, il n'y a pas de problème au niveau de la protrombique.

Donc, il sera plutôt positif. Et il sera négatif au cours d'un suivi d'un ICTER cholestatique où il y a une attente de la fonction de la fabrication, des facteurs de coagulation. Est-ce qu'une hépatomégalie définit un ICTER cholestatique ? Non.

C'est un signe qui est associé à la spénomégalie. Dans quel syndrome est-ce qu'on retrouve une spénomégalie ? Septicémie. Oui, mais on est pathologique.

Dans quel syndrome est-ce qu'on retrouve aussi une spénomégalie ? On vous a parlé d'hypertension portale ? Non. Au cours de cette spénomégalie, vous n'avez pas parlé de l'hypertension portale ? Donc, comme vous avez dit, les signes en faveur d'un ICTER cholestatique sont le prurite, parce qu'il y a un dépôt de celles biliaires sous la peau. On avait dit que l'ICTER cholestatique, c'était quoi ? C'était secondaire à un obstacle, un défaut de passage de la bile.

Donc le prurite, parce qu'il y a un reflux. Et on a aussi les selles décolorées. Le test de cholère, il sera positif.

L'hépatomégalie et la spénomégalie sont des signes qui sont associés. S'il vous plaît madame, je n'ai pas compris ce principe de test de cholère. J'arrive, je vais vous le dire.

Le test de cholère consiste en l'injection ou l'addition de vitamine K. Alors, au cours de la cholestase, où il y a un défaut de sécrétion biliaire, est-ce qu'il y a une absorption des vitamines liposolubles ? Dites-moi. Est-ce qu'il y a une absorption des vitamines liposolubles quand il y a un déficit ? Non. Dites-moi.

On va avoir une malabsorption des vitamines liposolubles. On va avoir une malabsorption des vitamines liposolubles. Et quelles sont les vitamines liposolubles ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà.

Alors, est-ce que la vitamine K, à quoi est-ce qu'elle sert finalement ? Quel est le rôle de la vitamine K ? La coagulation sanguine. Voilà. Donc, quand il y a un problème d'absorption de la vitamine K, il va y avoir un TP qui sera éliminé.

Si on ajoute de la vitamine K au cours de la cholestase pour compenser, il y aura une fabrication de quoi ? Par le foie. Est-ce que le taux de prothrombine sera... Plutôt, est-ce que la prothrombine sera fabriquée ? Oui. Pourquoi ? Parce que le foie fonctionne.

Et que le problème, il n'est pas au niveau du foie. Le problème, il est au niveau de malabsorption de la vitamine K. Donc, le taux de... le test de cholère sera positif. Dans le cas de l'insuffisance hépatocellulaire, où le foie est défaillant, si vous rajoutez de la vitamine K, est-ce que le foie est capable de fabriquer des choses et des facteurs de coagulation ? Non.

Donc, il y aura un test de cholère qui sera négatif. Vous pourrez rajouter autant de vitamine K que vous voudrez, il sera négatif. Vous avez compris le principe ? Oui.

Voilà. Donc, simplement, pour vous rappeler, la physiopathologie des dictaires, on avait dit que c'est une augmentation de production d'huile d'urine, soit qu'il y avait une hémolyse qui était pathologique, soit qu'il y avait un défaut de métabolisme d'huile d'urine, soit un défaut de l'excrétion, soit une anomalie de l'évacuation de la bile, et c'est la cholestase. Et qui dit anomalie de l'évacuation de la bile, va dire qu'il n'y a plus de bile pour assurer l'absorption.

Et c'est ça qui va faire qu'il n'y a pas d'absorption de beaucoup de choses, dont les vitamines liposolubles, et qu'il peut y avoir, bien sûr, un défaut, une diminution des facteurs de coagulation. Mais si on rajoute la vitamine K, il n'y aura pas de problème. Le défaut de métabolisme, je vous rappelle, que c'était soit total niveau la bile d'urine, c'était la maille de Gris-Garnager, soit partielle à la maille de Gilbert.

Et il y avait donc, bien sûr, des causes médicamenteuses, de défaut de conjugaison, qui étaient dues aux antibiotiques. Et le défaut d'excrétion, c'est quand le problème se produit en bas de la cellule. C'est-à-dire qu'il y a un défaut.

Il y a une glucoreconjugaison qui est faite, mais ce n'est pas excrété. Et donc, il va y avoir un reflux de bile d'urine conjuguée. Et globalement, c'était ces diapositives qui étaient importantes pour vous montrer qu'il y avait des causes de l'écholestase intrahépatique et des hépatites virales médicamenteuses, et qu'il y avait tout ce qui était obstacle ici, qui occasionnait une cholestase extrahépatique.

Ça pouvait être soit un calcul, soit une tumeur, soit une tumeur de la tête du pancréas y compris. Et ça, c'est pour vous rappeler que les dictaires peuvent être préhépatiques, hépatiques ou

posthépatiques. La coloration des urines, globalement, quand ce sont des dictaires à bile d'urine libre, elles sont claires.

Quand ce sont des dictaires à bile d'urine conjuguée, il y aura une des dictaires à urine foncée et à celles décolorées, donc les celles qui sont blanc-mastique. Et ça, c'est le syndrome de cholestase. C'est quand il y a, suite à une obstruction ou à une diminution de sécrétion, la bile d'urine conjuguée qui va refluer, il y aura un dictaire avec des urines foncées et des celles décolorées.

Il y aura aussi une stéatorée. Cette stéatorée est secondaire à quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une stéatorée ? Parce qu'il y a une malabsorption des graisses et qui vont aller dans les celles, donc être absorbées. Il y a aussi une malabsorption des vitamines A, D, E, K. Et comme il y a un dépôt de celles biliaires, il y aura des lésions de grattage.

Et ça, en sémiologie, vous devez examiner vos patients et voir s'il y a des lésions de grattage chroniques ou pas. Ça ressemble à ça. Et il y a également des xanthomes.

Les xanthomes, c'est ça, qui sont des dépôts de cholestérol qui vont aller sous la peau. Et vous allez observer souvent, chez les gens que vous connaissez, ces lésions autour de l'œil et ailleurs. Donc, les principales étiologies... Vous avez des questions ? Madame, j'ai dit des prurites aussi.

Pardon ? Rita, dites-moi. Madame, j'ai dit des prurites aussi. Les prurites, bien sûr, parce qu'il y a des dépôts de celles biliaires sous la peau.

Il y a des dépôts. Et quand vous allez faire la pathologie, vous allez avoir ce qu'on appelle les maladies cholestatiques chroniques, où il y a une destruction des voies biliaires. Au cours de ces maladies cholestatiques chroniques, il y a un prurite.

Vous allez entendre parler en pathologie de ce qu'on appelle la cholangite auto-immune. Et cette cholangite auto-immune, elle débute par un prurite, parce qu'il y a des dépôts de celles biliaires sous la peau. Et le traitement sera par des résines qui vont pouvoir aider à l'évacuation de la bile.

Vous allez voir ça en pathologie. Mais ce que vous devez apprendre en sémiologie, c'est surtout ce que c'est qu'un nictère, un nictère cholestatique, et les principales étiologies. Donc, pour revenir à notre... Voilà.

Je pense que nictère, en principe, est un cours qui est facile. Il ne vous créera pas de problème. Il n'y aura pas de surprise, le conserve.

Deuxième question. Vous avez fait la cite, je pense, avec Professeur Karati. N'est-ce pas ? Oui.

Oui. Donc, c'est une question que je vais vous poser parce qu'elle est un peu en... Comment vous dire ? C'est une... Elle est un peu en chevauchement avec les chapitres que je traite,

notamment la suissance hépatocellulaire et les autres. C'est juste pour savoir, en fait, si vous vous en rappelez ou pas.

Les caractères du liquide d'acide d'origine tuberculeuse sont... Est-ce que quelqu'un connaît les caractères d'acide d'origine tuberculeuse ? Est-ce que le liquide est trouble au cours de la tuberculose ? Oui. Est-ce qu'il est riche en protéines ? Oui. Très bien.

Est-ce qu'il est à prédominance pour le nucléaire notrophile ? Oui. Non. Oui.

Qui dit non, qui dit oui. Rita, c'est oui ou non ? Est-ce qu'il est riche en triglycérides ? Non. Madame Karati, je crois que c'est à prédominance régulière.

Oui. Alors, je vais vous donner la chose parce que je sais que là où vous êtes, ce n'est pas évident. Les caractères du liquide d'acide sont les suivants.

Rappelez-vous, s'il vous plaît, qu'un liquide d'acide est un liquide qui est clair. Il n'est pas trouble. Il est jaune citron.

Vous savez ce que c'est que jaune citron ? Citron, ça vient de citron. Donc, c'est un peu comme si c'était un jus de citron très dilué. D'accord ? Ou bien, si vous prenez une boisson diluée comme le Pums, par exemple, qui est jaune, et vous mettez beaucoup d'eau dedans, ça devient jaune citron.

C'est un liquide qui est clair, qui est jaune citron, qui est riche en protites, vous avez raison, qui est riche, qui est lymphocytaire, qui est à prédominance lymphocytaire. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de glu blanc, mais il y aura une hyper-lymphocytose. Et il n'est pas riche en triglycérides.

Donc, la seule réponse qui soit juste, c'est un liquide qui est riche en protites. Alors, cette question-là, il faut se la rappeler, parce qu'elle est hyper posable, que ce soit maintenant ou plus tard, en pathologie. Les caractéristiques d'un liquide jaune citron, plutôt d'un liquide d'acide d'origine tuberculeuse, il faut le connaître, c'est un liquide qui est jaune citron, qui est clair, qui est riche en protites, et qui est à prédominance lymphocytaire.

Il n'est pas à prédominance polythéotrophine, ni à prédominance en triglycérides. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que chileux ? Vous ne vous rappelez pas le cours d'acide ? Le mot chileux n'est pas sorti ? C'est la présence de... De ? Riche en triglycérides. Vous avez raison.

Et quand il est chileux, il est lactésan, comme du lait. Là aussi, imaginez du lait qui est dilué. Quand il est chileux, riche en triglycérides, il est lactésan.

Par contre, le liquide de la tuberculose, il est clair, il est jaune citrin, il est à prédominance lymphocytaire. Alors on va passer au chapitre qui nous intéresse. La constipation, cette année,

est-ce que vous avez des questions particulières ? Parce que j'ai un petit peu arrangé le cours, je l'ai simplifié.

Est-ce que vous avez des questions ? La constipation, vous savez, c'est extrêmement simple. Il faut connaître la constipation organique et la constipation maladie. Et il faut savoir qu'il y a des constipations de progression, qu'il y a des constipations terminales.

Et puis pour les organiques, c'est généralement quand il y a un obstacle quelque part ou bien une maladie qui paralyse un peu le côlon. Est-ce que vous avez des questions en particulier ? Donc on va commencer par la QCM. Après, on va voir le cours ensemble, si vous avez des questions.

Dites-moi. Madame, est-ce que la constipation fonctionnelle, elle fait partie de la constipation en maladie ou bien de la constipation en symptômes ? Je vais voir le cours avec vous. Répondez-moi d'abord à la QCM et je vous ouvre le cours immense pour voir ça à l'exemple.

Une constipation se définit par la présence d'une incontinence anale. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Hein ? Non. Faux.

C'est facile. Incontinence anale, c'est pas. Le nombre de selles inférieures à trois par semaine.

Oui. C'est la définition même. Vous avez raison.

La présence d'émissions gléose associées. Est-ce que ça rentre dans la définition de la constipation ? Non. Non.

La difficulté à l'exonération. Est-ce que ça rentre dans la définition de la constipation ? Oui. La distension abdominale associée.

Souvent, les gens qui sont constipés, ils ont des gaz parce que c'est logique. Ça ne sort pas, donc il y a une accumulation. Est-ce que la distension abdominale rentre dans la définition de la constipation ? Je vous ai désorienté.

Non. Est-ce que ça rentre ? Voilà. On est d'accord.

Donc, une constipation se définit par le nombre de selles inférieures à trois par semaine, la difficulté à l'exonération. Donc, en principe, c'est des questions qui sont extrêmement faciles. Vous n'allez pas être perdus.

Et là, je vais vous répondre à votre question. Il faut juste que je trouve mon cours. Il est là.

Et on va le voir ensemble. Voilà. Donc, on a défini ensemble au cours du cours, et c'est bien de revenir toujours, le symptôme qui est la constipation qui correspond à une insatisfaction, la défécation.

Et je vous avais dit en cours, pour les gens qui ont écouté, que la définition, c'est quand on a une insatisfaction. C'est-à-dire même quand on fait plus de trois selles par semaine et qu'on n'est pas satisfait, c'est une constipation. C'est moins de trois selles ou bien une difficulté à l'exonération, ou bien l'association des deux.

Une insatisfaction, la défécation, fait partie donc de la constipation. La physiopathologie, je vous ai dit que il y a la constipation maladie où le problème, c'est un mécanisme de la progression, soit une inertie colique, ça veut dire un côlon qui est paresseux, vous entendrez ce mot très souvent chez les patients, soit un côlon qui est spastique, et dans ce cas-là, il y a des spasmes, il y a des douleurs associées, soit une anomalie d'évacuation qui est la dyskésie. Donc, HADI, c'est la constipation maladie.

La constipation maladie, deux mécanismes, soit un mécanisme de progression, soit un problème ici. C'est ce qu'on appelle la dyskésie. Après, il y a la constipation symptôme.

Celle-ci, elle est récente, elle est secondaire. Elle peut s'accompagner d'autres choses et ces choses-là desquelles elle peut s'accompagner, c'est surtout des choses qui orientent à une maladie organique. Et j'ai fait cette part des choses parce que c'est vraiment deux choses qui sont différentes.

Quand on est constipé, parce qu'on a un côlon qui est paresseux ou parce qu'on a une dyskésie, on a une constipation qui est ancienne, qui est dans le temps. La constipation symptôme, c'est une constipation qui est souvent due à un problème. Elle est secondaire.

Elle s'accompagne d'autres signes. C'est pour ça qu'on faisait le diagnostic positif de la constipation et on recherchait à l'interrogatoire toujours les antécédents et puis on recherchait les événements récents, les prises médicamenteuses, les allitements. On recherchait les antécédents familiaux parce que le cancer du côlon peut avoir une forme familiale.

Et on cherche la circonstance, la date de survenue, si la constipation est ancienne ou récente. Si vous avez une femme qui vous dit depuis sa genoue ou le ventre consultation de toute ma vie j'ai été constipé, ce n'est pas la même chose que si vous avez une femme qui vient vous voir parce qu'elle a des rictoragies et qu'elle est constipée depuis un mois et qu'elle a perdu 10 kg en un mois. Ce n'est vraiment pas la même chose.

Il y a la constipation maladie et la constipation symptôme. Et on cherche aussi, bien sûr, on cherche les changements de conditions de vie et d'hygiène, les prises médicamenteuses. On cherche également les douleurs, les signes associés aux douleurs abdominales, les évacuations anormales.

C'est très important parce que ça peut orienter vers un cancer, le retentissement sur l'état général. Et on fait un examen physique qui est complet et qui va être complété par un toucher rectal et un examen proctologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute la pathologie proctologique.

Il y a tout ce qui est prolapsus, tout ce qui est fissure, tout ce qui est prolapsus hémorroïdaire. Ça, c'est un prolapsus rectal. Et ça, c'est un prolapsus hémorroïdaire qui vont expliquer qu'on puisse être constipé.

Parce que quand on a ça ou ça, on ne peut pas avoir des scènes normales. Et on fait le toucher rectal parce qu'on peut avoir des sténoses, on peut avoir des contractures paradoxales du sac interanal, c'est-à-dire que quelqu'un, vous lui mettez le doigt, vous avez une contraction. On peut avoir une présence de matière fécale et ça oriente vers le caractère terminal de la constipation.

Et bien sûr, c'est à partir de là qu'on pense à des examens complémentaires. Je vous ai dit dans le cours que les examens complémentaires, il faudra être orientés. Parce que si on fait des examens complémentaires comme ça, on peut se demander tous les examens complémentaires du monde.

Il faut d'abord faire un interrogatoire, un examen clinique, s'aider en constipation maladie, constipation organique. Et puis, bien sûr, en fonction de l'orientation, demander des choses. Si on a, par exemple, des glaires et du sang, je vais commencer par faire une rectoscopie, une coloscopie.

Si j'ai quelqu'un qui est ralenti, qui a pris du poids, qui a de l'œdème, à l'examen de la thyroïde, j'ai un nodule, je vais demander dosage des hormones thyroïdiennes. Et comme ça. Et si je suspecte, bien sûr, ce qu'on appelle une constipation fonctionnelle, et là, la constipation fonctionnelle, la constipation fonctionnelle, ta question y mène, c'est ça ? La constipation fonctionnelle ? Oui, madame, c'est ça.

J'y arrive, t'inquiète pas. Si je pense à une constipation fonctionnelle, parce que la constipation fonctionnelle, là aussi, c'est... J'arrive pas à remonter. Voilà.

La constipation fonctionnelle, c'est quand il y a un problème, soit d'inertie, un colon qui est paresseux, soit un problème de spastique, soit un problème de dysquiesie. Et dans ce cas-là, la constipation fonctionnelle, c'est plus un problème qui est vraiment maladie, quoi. Donc, on fait la mesure du transit colique pour voir s'il y a un problème de constipation de progression, c'est-à-dire qu'on va faire avaler au patient du rouge carmin ou un marqueur et on va attendre la déphécation.

Si c'est un problème qui est de dysquiesie ou de plancher, on peut faire une déphécographie, une déphéco-IRM, et si c'est un problème de sphincter, on va faire une manométrie. Et puis, pour les causes organiques et la constipation maladie, c'est ce qu'on appelle la constipation fonctionnelle, c'est des anomalies de progression et des anomalies d'évacuation. Alors, quand je vous dis constipation fonctionnelle, c'est fonctionnelle comme fonction.

C'est comme trouble fonctionnel intestinal ou trouble fonctionnel de l'œsophage. C'est-à-dire qu'on a ce qui est organique, réellement, c'est-à-dire que quand il y a un organe qui est malade, un

cancer, une tumeur bénigne, une sténose, une fissure, et il y a, réellement, ce qui est fonctionnel quand c'est un problème de progression ou un problème d'exonération. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir.

C'est plus facile pour vous parce que vous pourrez mieux, comme ça, faire l'enquête étiologique et prescrire, en fait, les explorations. Et c'est plus simple. Alors, il y a aussi une question qu'on pose très souvent.

On a toujours tendance à poser, après la définition, c'est ça. Quels sont les signes d'alarme au cours d'une constipation ? Qu'est-ce qui, vous, vous fait demander une coloscopie à votre patient ? Est-ce que vous les connaissez ? Quels sont les signes d'alarme ? C'est une question qui revient tous les ans. Une intération de l'état général, voire un amaigrissement.

Les douleurs surviennent. Les douleurs surviennent. Arrêt d'orage.

Quelles sont les choses qui... Quels sont les signes d'alarme pour vous qui vous font demander... Morts. Oui, c'est bien, Ariane. Globalement, quand est-ce que vous, vous êtes médecin, vous allez demander une coloscopie ? Est-ce que quand votre patient a une constipation qui est récente, une constipation qui est ancienne, quels sont les signes d'alarme pour vous ? Dites-moi.

Un amaigrissement. Quand il y a... Exactement. Quand il y a des signes.

C'est-à-dire que, quand votre patient est dérangé par sa constipation et que vous sentez qu'il y a un impact sur sa vie, c'est-à-dire qu'il y a soit un amaigrissement, soit une intération de l'état général, soit une anémie, soit qu'il vous rapporte un syndrome rectal, des épreintes, des ténèsmes. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un syndrome rectal ? Vous vous rappelez ? Épreintes, ténèsmes, faux-besoins ? C'est quoi, les épreintes ? C'est des douleurs à quel niveau ? Au niveau du coulant. Les épreintes, ce sont des douleurs qui surviennent, que vous sentez au niveau... vers le cible moide.

Voilà. Des ténèsmes, c'est des sensations de tension au niveau de l'anus et des faux-besoins, c'est quand il va aux toilettes, il fait des glaires au lieu de faire des besoins, parfois du sang. Quand la constipation est récente ou bien qu'il y a une aggravation de la constipation ancienne, je vous ai mis cette phrase parce que des fois, on se fait leurrer.

Vous avez des gens qui ont une constipation maladie, puis un côlon qui est paresseux. Cependant, rien ne l'empêche de faire un cancer du côlon. Donc, quand il est constipé depuis des années et qu'il vous rapporte des signes organiques ou bien qu'il a une aggravation de la constipation, il faut penser à lui faire une coloscopie.

Et quand vous avez des signes en faveur d'une cause organique, ça veut dire que cette personne-là, elle a une masse abdominale, elle n'est pas trop mégagnée avec une constipation, tout ça vous oriente vers ce qui est pathologique, essentiellement les cancers ou d'autres

maladies comme les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc, cette page-là, ou plutôt cette idée-là de chercher les signes d'alarme, elle est très importante. Il faut connaître les signes d'alarme.

Avant, on disait l'âge âgé au-delà des 45 ans, des 50 ans. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'âge à faire un cancer. Donc, on peut avoir des cancers chez des sujets qui sont très jeunes.

Dès que vous avez des signes d'alarme, amaigrissement, anémie, sang, glaire, constipation récente qui vous dérange, ou bien aggravation de constipation ancienne, des douleurs abdominales, rajoutez les douleurs abdominales. Parce que si vous avez des épreintes, des ténèbres, des douleurs avec la coloscopie, avec la constipation, il faut faire une coloscopie. C'est ce que j'ai appelé les signes en faveur d'une cause organique.

Les douleurs abdominales, c'est des signes en faveur d'une cause organique. Alors, on va fermer ça, et puis on va continuer dans notre petit échange. Tout à l'heure, on a parlé des caractères, la constipation, et puis là, je vais passer à l'insuissance hépatocellulaire.

L'insuissance hépatocellulaire se caractérise par quels sont les signes en faveur d'une insuissance hépatocellulaire ? Dites-moi, asthénie profonde, fièvre, hémorragie gingivale, coma avec signe de localisation, ictère fébrile. Est-ce que l'asthénie profonde est un signe en faveur de l'insuissance hépatocellulaire ? Oui. Oui, et je vous avais dit dans le cours que c'est un des premiers signes en faveur d'une insuissance hépatocellulaire, qu'on a souvent des patients qui sont cirotiques, qui ont des hépatopathies, qui sont diagnostiquées précocement par cette asthénie.

Est-ce que la fièvre est en faveur d'une insuissance hépatocellulaire ? Non. Non ? Non. Alors, on peut avoir, bien sûr, une infection liquide d'acide, quand on est cirotique, et avoir de la fièvre, mais ce n'est pas un signe en faveur d'une insuissance hépatocellulaire elle-même.

Une hémorragie gingivale, est-ce qu'elle est en faveur d'une insuissance hépatocellulaire ? Oui. Oui. Toutes les hémorragies, parce qu'il y a un syndrome hémorragique, parce qu'il y a un défaut de synthèse, bien sûr, des éléments de coagulation.

Donc, ce sont des patients qui vont faire des épistaxis, qui vont faire des hémorragies gingivales, qui vont saigner de partout. Est-ce qu'un coma avec signe de localisation est en faveur d'une insuissance hépatocellulaire ? Faux. Non.

Qui a dit oui, qui a dit non ? Faux. Non. Faux, parce qu'il y a un signe de localisation.

Au cas où l'insuissance hépatocellulaire, ce sont des comas sans signe de localisation. Voilà. Donc, vous avez l'asténie profonde, et vous avez l'hémorragie gingivale, et je reviens encore une fois à mon cours.

Voilà. C'était pour vous dire ça, que l'encéphalopathie hépatique, regardez, je vous l'ai bien dit,

ensemble des manifestations neuropsychiatriques, vous avez au stade 1 l'astérisis, qui est interruption brusque et brève du tonus de base. Au stade 2, avec un syndrome confusionnel.

Au stade 3, c'est un état stuporeux, c'est-à-dire qu'il y a de la stupeur. Le patient est dans un état de stupeur, c'est-à-dire un état de... c'est comme s'il avait la bouche ouverte, qu'il était surpris. Il est un peu dans les vapes.

Une somnolence marquée, il commence à avoir un discours inapproprié. Et le stade 4, c'est le coma sans signe de localisation. Ce n'est pas un problème au niveau du cerveau, ce n'est pas un traumatisme ou une tumeur, et il y a une hypertonie et une polypnée.

Et ça, c'est l'astérisis. Dans les services, vous l'avez vu, on demande aux patients de maintenir ce mouvement, mais il en est incapable de maintenir cette position. Et ses doigts, donc, sont tremblotants.

C'est quelque chose qu'on fait toujours dans la consultation. Donc, après, vous avez les autres manifestations. Et parmi les manifestations, vous, bien sûr, tout ce qui est hémorragie gingivale, épistaxis, purpura, échymose, et vous avez les autres signes.

Nous avons un autre diapositive. Alors, après, je passe à la diarrhée motrice, au diarrhée, tout simplement. S'il vous plaît, madame, j'ai une question.

Très bien. Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, l'hypervulure est bien émise. Est-ce qu'elle est à prédominance conjuguée, bien mixte ou bien libre? Très bien.

Bonne question. À votre avis, réfléchissez. Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, est-ce qu'il y a la glucoroconjugaison qui marche encore? Non.

Il y a encore des hépatocytes qui sont vivants, et il y en a d'autres qui sont morts. Alors, est-ce qu'il y a la glucoroconjugaison qui marche encore un peu dans ceux qui sont vivants, mais chez les autres, non? Après, est-ce que la fonction d'excrétion marche encore? Non. Au cours de l'insuffisance hépatocellulaire, on a des hépatocytes mixtes, parce que le problème touche les hépatocytes.

Et que ce soit la glucoroconjugaison ou l'excrétion, ce sont des fonctions de l'hépatocyte. Donc, on aura un problème, c'est-à-dire que dans certains hépatocytes, il va y avoir un trouble de glucoroconjugaison, et il y aura un reflux de bilirubine qui sera libre, parce qu'elle n'a jamais été glucoroconjuguée. Et dans d'autres hépatocytes, il y aura une glucoroconjugaison, mais il y a un problème d'excrétion, et il va y avoir un reflux de bilirubine conjuguée.

Donc, il va y avoir une bilirubine qui est, une hyperbilirubinémie qui est mixte. D'accord madame, merci beaucoup. Après, parce que c'est plus compliqué, plus subtil que ça, c'est-à-dire que si vous avez une cholangite auto-immune, où il y a un problème de destruction au niveau des voies

biliaires, qui évolue vers la cirrhose et le problème de la suffisance hépatocellulaire, vous pouvez avoir plus la composante conjuguée qui est prédominante.

Mais dans une suffisance hépatocellulaire, vous réfléchissez comme ça, je vous l'ai expliqué comme ça, vous avez un problème au niveau de l'hépatocyte qui est détruit. Il sera détruit au niveau de toutes ses fonctions. Donc, il y aura une hyperbilirubinémie qui sera mixte.

Donc, on passe ensuite à ça, au diarrhée. Alors, diarrhée chronique, où je vous avais parlé de la diarrhée motrice, et quels sont les éléments évocateurs d'une diarrhée motrice ? Est-ce que c'est la réponse au ralentisseur de transit ? Est-ce que c'est l'envie impérieuse d'aller au sel ? La présence de glaire et de sang dans les sels, l'association d'améliorismes importants, l'association des signes de malabsorption. Alors, question A. Est-ce qu'une diarrhée motrice répond au ralentisseur de transit ? C'est facile.

Oui. Pourquoi ? Parce que le problème de la diarrhée motrice, c'est que le transit est accéléré. Si vous donnez des ralentisseurs, ça va répondre et il y aura une amélioration.

Est-ce qu'il y a une envie impérieuse d'aller à la selle ? C'est-à-dire que la personne mange et doit partir en courant. Oui. D'ailleurs, quand vous demandez à votre patient d'écrire un petit peu ce qu'il ressent, souvent, les patients vous disent « Je suis très dérangé, je ne peux pas avoir de vie sociale, je ne peux pas manger chez la famille, je ne peux pas manger avec des amis, parce que dès que je mange, je dois trouver des toilettes à côté.

» Est-ce que la présence de glaire et de sang dans les sels est en faveur d'une diarrhée motrice ? Non. Non, c'est plus quelque chose qui est organique, un cancer ou une infection. Est-ce qu'une diarrhée motrice peut être associée à un amaigrissement important et à une altération de l'état général ? Oui.

Mais ce n'est pas un élément qui est évocateur d'une diarrhée motrice. Elle peut être associée, mais c'est vrai. Moi, je vous l'ai dit.

Je vous ai écrit. Il faut toujours lire comment c'est écrit, parce que c'est difficile de vous faire décussier un peu plus facile que ça. Les éléments évocateurs d'une diarrhée motrice sont est-ce que le fait d'avoir un amaigrissement et une altération de l'état général est évocateur d'une diarrhée motrice ? Non.

Par contre, au cours, par exemple, d'une hyperthyroïdie, on peut avoir une diarrhée motrice et un amaigrissement et une altération de l'état général. Mais ce n'est pas évocateur de la diarrhée motrice elle-même. La diarrhée motrice, c'est quelqu'un qui répond au ralentissement de transit et qui a une envie impérieuse d'aller à la selle.

OK ? Vous avez compris la nuance ? Oui, madame. Donc, ne vous compliquez pas l'existence. Il n'y a pas de piège.

Il faut juste lire l'énoncé. Madame ? Oui ? Ariane ? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de diarrhées à la fois ? Une diarrhée motrice et en même temps exudatives ? À votre avis, dites-moi. Est-ce que quelqu'un qui a, par exemple, une diarrhée motrice, ça peut être le trouble fonctionnel intestinal.

Est-ce que quelqu'un qui a un trouble fonctionnel intestinal n'a pas le droit de faire un cancer ? Il a le droit de faire un cancer. Madame, s'il vous plaît, dites-moi. Et maintenant, pour le test, comment on va pouvoir faire le test ? Parce qu'au niveau de la motricité, on va retrouver du sang.

Ça peut atterrir le diagnostic. Non, mais on va faire... Ariane, parce que je vous avais dit, quand on a un problème de transit avec des signes de gravité, c'est-à-dire que si on commence à avoir du sang chez quelqu'un, il faut explorer. On ne va pas faire le test, on va faire la coloscopie en premier.

Parce qu'une diarrhée ou un problème fonctionnel n'a jamais tué personne. Par contre, un cancer ou une maladie inflammatoire ou un problème ischémique, il peut être mortel. Donc, si on a du sang, des glaires dans le côlon, dans les selles, on va faire d'abord la coloscopie.

On ne va pas faire le test au rouge garmin pour éliminer quelque chose qui est fonctionnel. La conduite change. Ça, on le voit en pathologie, quand on a des patients qui ont des maladies de Crohn.

Quelqu'un qui a une maladie de Crohn, il peut très bien aussi être colopathe fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va vous faire une diarrhée qui n'est pas dérangeante. Une à deux fois par jour quand il mange, il va aux toilettes en courant, mais il n'y a pas de glaire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de retentissement avec des tests qui sont en train de réunir. Mais si un jour, cette même personne vous fait du sang avec des douleurs abdominales et avec un améliorement, il faut aller faire une coloscopie.

Il ne faut pas faire des tests à la recherche de quelque chose qui est fonctionnel. Vous avez compris, Ariane ? D'accord. Voilà.

Donc, ce n'est pas des maths. Ce sont des choses de la vie avec des nuances. Il faut juste comprendre les nuances.

Et ce n'est pas des pièges. Donc, les signes évocateurs d'une diarrhée motrice, c'est la réponse au ralentissement de transit et une envie impérieuse d'aller à la selle. Et les patients vous disent qu'ils retrouvent souvent des aliments qui ne sont pas digérés, parce que le problème, c'est la rapidité du transit.

Alors, les principaux diagnostics différentiels d'une diarrhée chronique, c'est extrêmement facile. Est-ce que la fausse diarrhée de constipation est un diagnostic différentiel ? C'est facile. C'est quoi la fausse diarrhée de constipation ? C'est quelqu'un qui est constipé.

C'est quelqu'un qui est constipé pendant longtemps, puis il évacue et il va évacuer beaucoup. Ça peut être un diagnostic différentiel d'une diarrhée, plus aiguë que chronique, mais c'est un diagnostic différentiel. Est-ce que l'incontinence anale est un diagnostic différentiel ? Oui.

Oui. Oui. Donc, la diarrhée motrice, ce n'est pas un diagnostic différentiel, c'est une étiologie.

La diarrhée aiguë prolongée, oui. Je vous l'avais expliqué. Dans le diagnostic différentiel, c'est pour ça qu'on n'avait qu'un jour pour la diarrhée aiguë et quatre semaines.

On se laissait une semaine pour bien réfléchir. Pour bien, bien, bien réfléchir. Donc, prenez le temps de voir avec moi la définition.

La physiopathologie des diarrhées chroniques, je vous avais dit qu'il y avait les diarrhées par malabsorption. Vous allez les voir tout le temps. Les diarrhées sécrétoires, les diarrhées osmotiques, les diarrhées motrices et les diarrhées excudatives quand il y a une fuite dans le tube légitime des composants sanguins et qu'il peut y avoir des associations.

Alors, après, je vous avais dit, ça c'est le bilan de retentissement pour les autres et puis je vous avais expliqué, je vous l'ai trouvé, le test au rouge carmin dont parlait Ariane, le test au rouge carmin, c'est surtout pour la diarrhée motrice. Alors, si la première selle apparaît après moins de 8 heures et la dernière selle disparaît en moins de 24 heures, c'est qu'il y a un problème diarrhée motrice. Et la diarrhée motrice, ses principales écologies, c'est la colopathie fonctionnelle.

Et comme je vous ai dit, rien n'empêche un colopathe fonctionnel de faire un cancer du colon. C'est pour ça qu'il faut être malin. C'est-à-dire, il y a la colopathie fonctionnelle qui n'exclut personne, mais si j'ai des signes de gravité, si j'ai quelqu'un qui a des antécédents de cancer, il faut lui faire la coloscopie pour dépister.

Il y a ce qui est hormonal, les hyperthyroïdies, les tumeurs carcinoïdes, et il y a ce qui est neurologique et neuropathie diabétique. Et les autres étiologies de diarrhée, ce sont, bien sûr, les diarrhées osmotiques. C'est essentiellement la prise de laxatifs osmotiques.

C'est pour ça que dès que vous arrêtez ces patients, vous les enfermez à clef, vous les faites jeûner, vous leur arrêtez les laxatifs, la diarrhée va régresser, et les carences en lactase. La diarrhée sécrétoire, qui sont abondantes, mais ce n'est pas au jeûne. Et puis, vous avez les diarrhées exudatives.

C'est quand il y a une suite des lésions ulcérées de la muqueuse avec une suite des composants du sang. C'est dans le cas des lymphomes, des maladies de Crohn et tant d'autres. Je vous rappelle cette diapositive pour voir qu'on fait le bilan initial avec un interrogatoire, l'examen clinique et l'examen complémentaire.

Quand c'est une diarrhée avec malabsorption, ça se voit. Ça se voit cliniquement, ça se voit

biologiquement, et dans ce cas-là, on a la diarrhée par maldigestion, qui sont des problèmes, d'insuffisance pancréatique exocrine, d'insuffisance biliaire, d'insuffisance des sécrétions gastriques. Ou bien on a les autres, les atrophies villositaires, que ce soit la maladie céliaque ou les autres, les entéropathies exudatives, la pullulation microbienne, les résorptions étendues du crête.

Et on a les diarrhées sans malabsorption. Les diarrhées sans malabsorption, c'est celles qu'on a eues. C'est OK pour les diarrhées chroniques ? Dites-moi, Bukri.

Oui. Allez-y. Oui, dites-moi.

Madame, s'il vous plaît, je n'arrive pas à comprendre la différence physiopathologique entre les diarrhées osmotiques et sécrétoires, à part que c'est au jeûne et la prise de laxatifs. C'est quoi une diarrhée osmotique ? Selon le conseil, c'est une diarrhée qui survient après un trop osmotique. Non, c'est quand on prend des substances osmotiquement actives et qu'on les ingère dans le côlon.

Ces substances osmotiquement actives, vous avez vu ça en pharmacologie, c'est les laxatifs. Vous vous rappelez, quand on a fait les laxatifs, on avait dit que quand on prenait des laxatifs osmotiques, il y avait un appel d'eau. Vous vous rappelez ? Oui.

Oui, j'espère. Donc, quand on prend des laxatifs osmotiques, il y a un appel d'eau. Et donc, dès que vous arrêtez la prise de ces laxatifs, la diarrhée arrête.

Donc, la diarrhée osmotique, en fait, c'est une diarrhée qui est secondaire, dans 90 % des cas, à une prise de substances osmotiquement actives. C'est soit du lactose, parce que vous avez une carence en lactase, soit des laxatifs osmotiques. Et c'est quelque chose qui est facilement réglé parce que, quand je dis jeûne, c'est isoler le patient et arrêter de lui donner des médicaments et des choses.

Là, il est démasqué parce qu'il prenait des laxatifs osmotiques et il les arrête. La diarrhée est partie. Par contre, une diarrhée sécrétoire, c'est une diarrhée qui est secondaire, en fait, à des tumeurs endocrines qui sécrètent, en fait, de la gastrine ou des choses.

Il y a une réelle sécrétion secondaire à, voilà, de gastrine ou de VIP. Vous avez compris la différence ? Oui, merci madame. Madame ? Oui ? Une diarrhée aiguë peut se transformer en diarrhée chronique.

Bien sûr. Bien sûr qu'une diarrhée aiguë peut se transformer en diarrhée chronique. C'est ce qu'on voit souvent dans le cas, par exemple, des maladies inflammatoires chroniques intestinales, que le début peut se manifester par une diarrhée aiguë.

Parce que, par exemple, il y a une surinfection anivienne et que, par la suite, en fait, il y a le processus inflammatoire qui va se déclencher. Et on peut avoir une diarrhée chronique. Bien sûr

qu'une diarrhée aiguë peut se transformer en diarrhée chronique.

Oui ? Madame, pour la diarrhée osmotique aussi, vous ne cédez pas aux gens comme le sécrétoire ? Pas toujours. Après, l'osmotique, vous avez l'épreuve du jeûne, elle n'est pas... L'épreuve du jeûne, ce n'est pas quelque chose qui réussit à 100%. Ce qui cède réellement, et là réfléchissez physiopathologie, ce qui cède réellement aux jeunes, c'est la diarrhée osmotique, parce que vous allez arrêter de lui donner soit du lactose, soit des laxatives, et c'est la diarrhée motrice, parce que quand il ne mange pas, il ne va plus aux toilettes.

Yep, ça paraît logique. Tout le reste, ça peut céder, comme ça peut ne pas céder, ou ça peut céder partiellement, s'améliorer. C'est pour ça que, quand je vous pose des questions, ou quand, dans la vie, vous allez réviser, ce qui cède au jeûne, c'est surtout la diarrhée motrice et la diarrhée osmotique.

D'accord ? Vous avez compris ? Oui. Ça veut dire qu'il est prouvé du... Oui. Madame, à quoi sert le test respiratoire ou glucose ? À votre avis, il va rechercher quoi ? Affection bactérienne.

Et quoi d'autre ? Comme son nom l'indique. Réfléchissez. Test respiratoire ou glucose.

Comme son nom l'indique, il recherche quoi ? À votre avis ? Dites-moi. Il cherche à mettre en œuvre les bactéries qui fermentent le glucose. Voilà.

Vous avez dit le mot que j'attendais. C'est la fermentation. C'est la fermentation.

Ça veut dire que, s'il y a un problème d'absorption, tout ce qui est sucre va rester et il va fermenter et on va le détecter. Ça veut dire qu'il y a un problème d'absorption de ces sucres. Le mot clé, c'est la fermentation.

Parce que ce test respiratoire ou glucose recherche essentiellement le sucre qui a fermenté et les bactéries qui sont secondaires à ça. C'est quelque chose qui met en valeur ou bien qui recherche un problème d'absorption, une diarrhée par malabsorption. Ensuite, la diarrhée aiguë.

La diarrhée aiguë, entéro-invasive. On avait la diarrhée aiguë qui était l'autre, qui était comment ? On l'appelait comment ? C'est très tôt. Oui.

Donc la diarrhée aiguë, la diarrhée aiguë, entéro-invasive, se manifeste par une dysenterie. Vrai ou faux ? Vrai. Par un syndrome dysentérique.

Est-ce qu'elle s'accompagne de douleurs abdominales ? Est-ce qu'elle peut s'accompagner de douleurs abdominales ? Oui. Est-ce qu'elle ne nécessite jamais d'exploration biologique ? Non. Faux.

Faux. Dès que vous avez une diarrhée aiguë, entéro-invasive, il faut faire des explorations biologiques, il faut faire des prélèvements de sel. Est-ce qu'elle peut être secondaire des agents

parasitaires ? Oui.

Oui. Est-ce qu'elle contraindique formellement une prescription de ralentissement de transit ?
Oui. Oui.

C'est facile, extrêmement facile. La diarrhée aiguë, entero-invasive, se manifeste par une dysenterie. Bien sûr, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on appelle la diarrhée dysentérique.

Elle peut s'accompagner de douleurs abdominales, évidemment, parce que, vous avez vu le mécanisme, c'est une altération de la muqueuse. Il peut y avoir de l'inflammation. Il peut y avoir, bien sûr, quand on mange, des spasmes, des spasmes spontanés.

Elle nécessite toujours des explorations biologiques. Elle peut être secondaire des agents parasitaires. Et elle contraindique formellement la prescription de ralentissement de transit, parce que si on prend des ralentissements de transit, il va y avoir une inertie.

On risque de déclencher ce qu'on appelle une colectasie et une perforation avec une péritonite, ce qui est une catastrophe. Donc, c'est ça la réponse. Ensuite, les diarrhées hydriques.

Il y a un sécrétoire. Est-ce qu'elles se caractérisent par des selles très abondantes ? Oui. Est-ce qu'elles sont souvent associées à des douleurs abdominales ? Non.

Est-ce qu'elles peuvent entraîner une déshydratation ? Oui. Est-ce qu'elles peuvent être virales ?
Oui. Bien sûr.

Est-ce qu'elles ne nécessitent jamais d'exploration ? Non. Non. Elles nécessitent parfois une exploration.

En fait, un truc que j'aime, c'est quand quelqu'un vous dit jamais, c'est qu'il n'y a jamais de grand jamais. Vous le savez. Donc, on va revenir au chapitre diarrhée aiguë.

Madame, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas bien compris quelle est la notion du ralentisseur du transit.

Le ralentisseur du transit aérien, c'est quand on prend un comprimé pour ne plus avoir de diarrhée. C'est un comprimé dont l'action sera, un médicament dont l'action sera d'arrêter ou de diminuer la motricité colique. Alors, imaginez un colon qui est plein de germes, qui est inflammé, vous arrêtez sa motricité.

Il y aura une pullulation des germes, il n'y aura plus d'évacuation et ça va accentuer leur caractère méchant et ça risque d'entraîner une perforation. Donc, deux types de diarrhées dont on a parlé, les diarrhées dites sécrétoires ou bien hydriques ou bien colériques, tous des noms que vous allez trouver, qui sont secondaires à une production de toxines, sécrétion d'eau, d'électrolyte avec des selles aqueuses et abondantes, dont le risque, surtout, c'est la

déshydratation. Et vous avez les diarrhées entéro-invasives, ces diarrhées dysentériques, où il y aura une lésion de la muqueuse avec des selles gléosanglantes et dont les principales complications sont les perforations, les hémorragies, la colectasie et le sepsis.

Le diagnostic positif, là encore, c'est simple et il y a la particularité qu'on fait de la diarrhée aiguë, ce sont des questions d'urgence, l'évaluation de gravité, l'évaluation du retentissement, la déshydratation, la tachycardie, l'hypotension, les SUA, le lingo-anurie et un facteur aggravant pour les diarrhées aiguës, ce sont les âges extrêmes, c'est-à-dire les enfants, parce qu'ils les hydratent et puis les sujets âgés, parce qu'ils risquent de vous faire des hématomes sodiaux. Et là aussi, on va les scinder, c'est cette diapo qui est importante. Vous avez les diarrhées invasives et les diarrhées sécrétoires.

Toutes peuvent être dues à des bactéries, des virus et des parasites. Et le traitement va reposer sur, regardez bien, régime sans résidu et repos, réhydratation, antispasmodique, anti-hémétique et les ralentisseurs de transit sont contre-indiqués sous diarrhées invasives. Pourquoi je vous les ai mis quand même ? Parce que des fois, on peut, un patient, on peut vous demander de lui donner un ralentisseur de transit.

Il faut savoir que dès que vous suspectez sur une diarrhée invasive, c'est une contre-indication absolue. Donc là, c'est extrêmement simple. Ensuite, ensuite.

Madame ? Oui ? Madame, j'ai une question. La colombe égale, c'est un signe de la constipation ? Un grand colombe ? Oui. Alors, ça peut être secondaire à une constipation, comme ça peut être une cause d'une constipation.

Parce qu'il y a des gens qui naissent avec des colombes qui sont très grands. Madame, la distension abdominale, c'est aussi un signe de la constipation ? C'est un signe qui peut être associé, mais ce n'est pas la définition de la constipation. Vous avez la définition en elle-même, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire insatisfaction, insatisfaction à la selle, moins de trois selles par semaine, difficulté d'exonération, insatisfaction, et vous avez les signes qui peuvent être associés.

Alors, une distension abdominale, ça peut être associé, sachant qu'une distension abdominale, ça peut être, le mot distension abdominale, ça peut être des gaz, comme ça peut être de l'acide. Donc, vous ne pouvez pas savoir quand vous avez une distension abdominale, il faut d'abord examiner votre patient, le palper, le percuter, peut-être même faire une échographie abdominale. Donc, ça ne rentre pas dans la définition des signes d'alarme ou constipation.

Et pour revenir ici, les signes d'alarme ou constipation sont la jeûne au moment du diagnostic, non, l'association à des rectoragies, oui, l'association à des douleurs abdominales diffuse, oui, l'association à des épreintes, oui, et un amaigrissement important, oui. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça, ce sont les signes d'alarme ou constipation qui imposent de faire un examen par colonoscopie.

Est-ce que vous avez des questions concernant les différents chapitres qu'on a vus ? S'il vous plaît, madame, c'est quoi une hépatite fulminante ? Une hépatite fulminante, c'est quelque chose que vous allez voir surtout en pathologie. Il faut savoir que quand vous avez une hépatite, elle peut se manifester par une destruction, basiquement. Elle peut se manifester par une destruction très rapide, donc, des hépatocytes.

Donc, ce qui va se manifester par un nictère, ce qui va se manifester aussi par une diminution très importante du TP, moins de 50%. Et c'est ce qu'on appelle fulminante. Fulminante, un peu, je pense que c'est la même racine étymologique que feu.

Et dans ce cas-là, on parle, donc, de cette hépatite fulminante. Donc, moins de 15 jours ou moins de 7 jours, vous avez une hépatite qui est, donc, vous avez une destruction très importante du parenchyme hépatique avec un nictère, avec une diminution du TP qui est importante. C'est quelque chose qui indique une transplantation hépatique.

Pourquoi ? Parce que c'est une urgence, le patient peut mourir. C'est ça, une hépatite fulminante. Vous avez compris ? Oui, madame.

Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Globalement, sur quelque chose. Madame ? Oui ? S'il vous plaît, vous pouvez nous déposer ce QCM sur la planète ?